

●輸血の単独ルートが取れず、他のルートから投与する場合●

輸液剤と混合すると赤血球の凝集や溶血が起こるので、輸血前後は、必ず、生理食塩水でラインフラッシュを行う。

● 既存の末梢ルートから輸血を開始する場合

末梢のメインルートを一時的にとめて血液の逆流を確認したあと、生理食塩水でラインをフラッシュ後、輸血バッグをつないだ輸血セットを側管に接続し開始する。

● CVから輸血を開始する場合

あくまでも末梢が第一選択。どうしてもルートが取れず、医師の許可がある場合のみCVルート。

メインルートから投与する場合は、生理食塩水でラインをフラッシュしてから、輸血バッグをつないだ輸血セットを、側管に接続し開始する。ダブルルーメンカテーテルの場合で、今まで使用していなかったサブルートを使用する場合は、カテーテル接続部にクレープコネクターが接続してあるのを確認した上で、Aセットに生食100mlをつないで接続し、滴下を確認してから、輸血バッグをつないだ輸血セットをAセット側管に接続し開始する。

●輸血による細菌感染を疑った時の手順 輸血バッグ等の処理方法●

細菌感染を疑う症状とは？

輸血実施中に、発熱(39℃以上または2℃以上の上昇)・血圧低下・頻脈・SPO2低下・消化器症状(嘔吐・下痢)が出現する。

- ① 輸血を止めすぐに医師に報告。中止指示があったら、輸血クランプを固く締め、留置針は残しセットごと外す。外したセット端には18G針をつける。
- ② 留置針内の血液をシリンジで吸引後、新しい生理食塩水をつないだセットをつなぐ。(医師の指示を確認する。)
- ③ 輸血バッグはセットをつないだまま、セットの点滴筒の上下のチューブを三つ折りにしてテープで止めバッグごとジップロックに入れ密封する。(セットからバッグ、点滴筒への血液の逆流を防ぐため。)
- ④ 検体運搬用の発泡スチロール容器に、ジップロックに入れて密封した保冷剤と、上記の輸血バッグセットを入れたジップロックを入れて、蓋をしっかり閉める。
- ⑤ 容器の上に「使用済み輸血」のカードを貼り検査室に持って行く。検査室スタッフが不在の時間は、自部署にそのまま保管し、検査室スタッフの出勤時に持って行く。)
- ⑥ 検査室は、赤十字血液センター医療情報担当者へ連絡し、必要があれば輸血バッグを提供する。